

01 / 08

La primera entrevista

Tiene una función diagnóstica y pronóstica. Permite evaluar el motivo de consulta, la demanda, la estructura subjetiva y la posibilidad de establecer un vínculo terapéutico. El objetivo inmediato es habilitar las condiciones para que el paciente pueda hablar.

Lo que el paciente trae en la primera sesión ya es clínico. Cómo empieza, por dónde entra, qué calla: todo es material.

Ejes de escucha clínica

- Motivo manifiesto: lo que el paciente dice que le pasa
- Motivo latente: lo que subyace, lo que aún no puede decir
- Demanda: qué espera del tratamiento, del terapeuta, de la psicología
- Nivel de sufrimiento: urgencia subjetiva, capacidad de tolerarlo
- Recursos: red vincular, tratamientos previos, mecanismos de afrontamiento
- Insight: cuánto puede observarse a sí mismo

Al cierre de la primera entrevista

- Dejar acordado si habrá continuidad y en qué condiciones
- Dar espacio para preguntas del paciente
- Si hay riesgo o crisis, abordarlo antes de terminar

02 / 08

Encuadre

El encuadre es el conjunto de condiciones invariantes bajo las cuales se desarrolla el tratamiento. Su función es crear un marco predecible que sostenga el proceso.

Elementos del encuadre

- Frecuencia: cuántas sesiones por semana
- Duración: generalmente 45–50 minutos
- Horario y lugar: fijo o variable, presencial u online
- Honorarios: monto, modalidad y día de pago
- Política de cancelaciones: anticipación requerida y si la sesión se cobra igual
- Confidencialidad: alcance y excepciones legales y éticas
- Comunicación entre sesiones: si existe, canal y función

El encuadre lo establece el terapeuta

Las condiciones del tratamiento las define el profesional desde un criterio clínico, no desde la urgencia de retener al paciente. La flexibilidad es posible, pero siempre como decisión fundamentada, no como respuesta a la presión.

Rupturas del encuadre

- Toda ruptura —falta, llegada tarde, no pago, cambios de horario reiterados— es material clínico
- No se ignora ni se normaliza: se trabaja dentro de la sesión

03 / 08

Honorarios y cobro

La relación del terapeuta con su honorario, con el cobro y con la deuda del paciente forma parte del campo clínico y de la contratransferencia.

Cómo definir el honorario

- Tomar como referencia los valores del mercado: colegio profesional, colegas, zona
- Considerar el nivel de formación propio y la experiencia acumulada
- Arrancar demasiado bajo dificulta las actualizaciones posteriores

Mecánica del cobro

- Definir el momento del pago con claridad desde el inicio: por sesión, semanal o mensual
- La deuda sostenida sin trabajarla deteriora el vínculo terapéutico

SESIONES CANCELADAS

Definir la política desde el inicio. Lo más habitual: se cobra si no se avisa con 24 o 48 horas.

INCOMODIDAD CON EL COBRO

La dificultad para cobrar o actualizar el honorario es material de supervisión y de análisis personal.

04 / 08

Historia clínica

Es un instrumento de pensamiento y un documento legal. Organiza la información relevante del caso, orienta la dirección del tratamiento y protege al paciente y al profesional.

Contenido mínimo

- Datos de identificación: nombre, edad, contacto, cobertura médica si tiene
- Motivo de consulta: en palabras del paciente y en la lectura del terapeuta
- Historia vital: infancia, vínculos significativos, hitos relevantes
- Antecedentes de tratamientos previos: con quién, modalidad, resultados
- Antecedentes de salud mental y física relevantes para el caso
- Situación actual: laboral, afectiva, familiar, económica
- Medicación: qué toma, quién la prescribe y desde cuándo
- Evaluación de riesgo cuando sea pertinente

NOTAS DE SESION

- No es una transcripción: es un registro de lo clínicamente significativo
- Incluye qué trajo el paciente, observaciones propias, intervenciones realizadas y lo pendiente
- Registrarlas lo antes posible después de cada sesión
- Son del profesional pero forman parte del legajo del paciente

Confidencialidad y resguardo

- La historia clínica es estrictamente confidencial. No se comparte sin consentimiento
- Excepciones: riesgo cierto e inminente para el paciente o terceros
- Ante la duda, consultar con supervisor antes de actuar

05 / 08

Conceptualización de casos

Conceptualizar es construir una hipótesis de trabajo clínico.

Preguntas que organizan la lectura clínica

- ¿Cuál es el sufrimiento central que presenta?
- ¿Qué lo llevó a consultar ahora y no antes? ¿Qué cambió?
- ¿Qué demanda hace? ¿Qué espera del tratamiento?
- ¿Qué repite? ¿Qué patrones se replican en sus vínculos y elecciones?
- ¿Cuáles son sus recursos y fortalezas disponibles?
- ¿Qué hipótesis puedo construir sobre el origen y función del sufrimiento?

La hipótesis de trabajo

- Responde: ¿qué le pasa? ¿por qué a él/ella? ¿qué función cumple el síntoma?
- Es provisional y revisable: se afina con el tiempo, las sesiones y la supervisión
- Orienta las intervenciones sin cerrar la escucha

Cómo presentar un caso en supervisión

- Contexto general del paciente, sin datos identificatorios innecesarios
- Por qué consulta y qué demanda hace
- Qué está pasando en el tratamiento, qué se intervino y con qué efecto
- Qué genera en el terapeuta (contratransferencia)

06 / 08

Intervenciones clínicas

Una intervención es todo acto del terapeuta que tiene efecto en el campo clínico. Incluye lo que se dice, cómo, cuándo, y también el silencio. Siempre tiene una dirección: no es espontánea ni azarosa.

La intervención más costosa suele ser la que se hace antes de tiempo. El timing es parte de la técnica.



Señalamiento

Se señala algo que el paciente dijo, hizo o evitó, sin interpretarlo aún. Abre la observación sin imponer sentido.



Reformulación

Se devuelve lo que el paciente dijo con otras palabras, para que se escuche desde afuera con cierta distancia.



Pregunta clínica

No se pregunta para obtener información, sino para que el paciente piense. '¿Qué pensás vos de eso?' es una intervención.



Confrontación

Se señala una contradicción o inconsistencia. Requiere alianza terapéutica. Sin ella puede vivirse como ataque.



Interpretación

Se propone una hipótesis sobre el sentido latente. Es la intervención de mayor alcance. Requiere timing, alianza y fundamento.



Silencio sostenido

No es ausencia: es presencia activa. Permite que el paciente habite lo que acaba de decir.

07 / 08

Errores frecuentes al arrancar

Los errores en los primeros años son parte del proceso de formación. El problema no es cometerlos: es no llevarlos a supervisión y repetirlos sin reflexión.

Querer entender todo rápido

Apresurarse por comprender viene de la ansiedad del terapeuta. La posición de 'no saber' es clínicamente válida.

Identificación excesiva con el paciente

Cuando el terapeuta se reconoce en la historia del paciente puede perder la distancia necesaria para trabajar. Va a supervisión y a análisis personal.

No sostener el encuadre por miedo a perder el paciente

Ceder sistemáticamente —no cobrar, cambiar horarios sin criterio— daña el tratamiento.

No ir a supervisión

La supervisión al inicio es una condición del ejercicio clínico responsable.

No ir a análisis personal

La contratransferencia existe en todos los casos. Si no se trabaja lo que el paciente moviliza en el terapeuta, eso entra en la sesión de formas que no se pueden controlar.

Miedos frecuentes en los primeros años (son esperables)

- Decir algo incorrecto y dañar al paciente
- Que el paciente no vuelva
- No saber qué hacer con el silencio
- No ser tomado en serio como profesional
- Que el tratamiento no avance

08 / 08

Derivaciones y límites profesionales

Saber cuándo derivar es una competencia clínica. Atender un caso que excede la formación actual pone en riesgo al paciente. Los límites propios son parte de la ética profesional.

Cuándo derivar

- El caso excede el nivel de formación o experiencia actual del terapeuta
- Hay patología que requiere otro abordaje o especialista (psiquiatría, neurología, etc.)
- Existe riesgo para el paciente o terceros que no puede manejarse solo

Cómo derivar bien

- Explicar el motivo con claridad
- No hacer una derivación abrupta: dar lugar a un cierre cuando sea posible
- Tener un profesional concreto al que derivar
- Registrar la derivación en la historia clínica

CONSULTA VS. DERIVACIÓN

Se puede consultar con otro profesional sobre un caso sin derivarlo. La consulta enriquece la mirada clínica y no es señal de incompetencia.